

// ENTENDA A DOR, VOLTE A SE MOVER

Dor Não É Sinal de *Parar*

Quase sempre. Parar tudo no primeiro incômodo costuma piorar. Entenda o que a dor é — e aprenda a se mover com segurança de novo.

Gustavo Correia Vieira

PREPARAÇÃO FÍSICA & PERFORMANCE

1ª Edição · 2026
Fontes A1/A2 · Qualis

Sumário

00	O Medo que Paralisa	03
	Por que parar tudo costuma piorar.	
01	O Que é a Dor	04
	Um alarme protetor, não um medidor de dano.	
02	Dor ≠ Dano	05
	"Desgaste" no exame não é o mesmo que dor.	
03	Dor Aguda × Crônica	06
	Quando o alarme é real e quando ficou sensível.	
04	O Alarme Sensível Demais	07
	Como o sistema "aumenta o volume" da dor.	
05	O Ciclo do Medo	08
	Dor → medo → parar → enfraquecer → mais dor.	
06	Movimento é Remédio	09
	Por que se mover, e não repousar, costuma curar.	
▶	Dor Inteligente + Bandeiras Vermelhas	11
	Quando seguir, quando parar e procurar ajuda.	
→	Seu Plano de Retorno + Avaliação	14
	Volte a se mover, com segurança.	

IMPORTANTE

Este guia é educativo e trata de **dores comuns e persistentes** e do retorno seguro ao movimento. Ele **não substitui avaliação médica**. Dor intensa após trauma, ou com os sinais de alerta da página 11, pede atendimento profissional.

// INTRODUÇÃO

O Medo que Paralisa

Sentiu uma fisgada nas costas, no joelho, no ombro — e parou tudo, com medo de "piorar". É a reação mais comum. E, na maioria das vezes, a errada.

Sou o Gustavo, preparador físico. A dor assusta — e o instinto manda proteger: parar, repousar, evitar. Para uma lesão aguda grave, faz sentido por alguns dias. Mas para a imensa maioria das dores comuns e persistentes, **parar tudo por tempo demais costuma piorar**: o corpo enfraquece, a região fica mais sensível, o medo cresce e a dor se instala. Você entra num ciclo do qual o repouso não te tira.

A virada começa por entender o que a dor realmente é. Ela não é um medidor confiável de dano nos tecidos — é um **alarme**, criado pelo cérebro para te proteger. E como todo alarme, às vezes dispara sem perigo real, ou fica sensível demais. Saber disso muda tudo: em vez de fugir do movimento, você aprende a usá-lo como remédio — com critério e segurança.

Este guia, baseado em evidência de alto nível (**A1/A2 no Qualis**), te dá esse mapa: o que é a dor, por que ela não é igual a dano, como sair do ciclo do medo, e — com responsabilidade — quando a dor **realmente** manda parar e procurar ajuda.



FIG. 00 · O MOVIMENTO CERTO FAZ PARTE DA CURA

A VIRADA DE CHAVE

"Dói" nem sempre significa "está se lesionando". Aprender a diferença é o que te devolve a liberdade de **viver e treinar** — em vez de viver em volta da dor.

// CAPÍTULO 01

O Que é a Dor

A dor não vem "do tecido" direto para você. Ela é produzida pelo cérebro — um alarme que pesa muitas informações antes de disparar.

Imagine os tecidos do corpo cheios de sensores que enviam sinais de "perigo" ao cérebro. Mas quem decide se você vai **sentir dor** — e quanta — é o cérebro, depois de avaliar o contexto: o quão ameaçadora ele julga a situação, as suas experiências passadas, o seu medo, o seu estresse, até o que você acredita sobre aquela dor. Por isso a mesma "lesão" dói diferente em pessoas (e momentos) diferentes.

Isso explica fenômenos curiosos: soldados feridos em batalha que não sentem dor na hora; pessoas com dores intensas sem nenhuma lesão detectável; o membro fantasma, que dói num braço que não existe mais. A dor é **real** em todos esses casos — mas ela é uma **experiência construída pelo cérebro**, não uma leitura direta do estrago.

A DEFINIÇÃO QUE LIBERTA

A dor é um **alarme de proteção**, não um medidor de dano. Como todo alarme, ela é útil — mas pode disparar sem perigo proporcional. Entender isso tira o pânico e devolve o controle.

POR QUE ISSO IMPORTA PARA VOCÊ

Se a dor é um alarme (e não a medida exata do dano), então **sentir dor não prova que você está se machucando**. Essa única ideia já muda a forma como você reage ao próximo incômodo — e abre a porta para se mover de novo.

// CAPÍTULO 02

Dor ≠ Dano

"Tenho uma hérnia, um desgaste, um 'osso roçando'." Esses achados existem — mas eles também estão no corpo de muita gente que **NÃO** sente dor nenhuma.

Uma revisão sistemática de referência examinou exames de coluna de milhares de pessoas **sem nenhuma dor**. O resultado surpreende: "desgastes" e alterações são comuns e aumentam com a idade — mesmo em quem não sente nada. Ou seja, encontrar uma alteração no exame **não prova** que ela é a causa da sua dor.

PESSOAS SEM DOR COM "DESGASTE" NO EXAME DE COLUNA (POR IDADE)

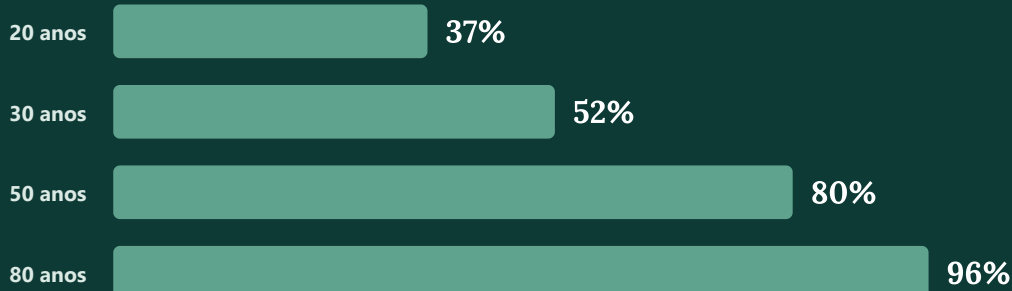


FIG. 02 · degeneração discal em pessoas assintomáticas: de ~37% aos 20 anos a ~96% aos 80 (Brinjikji et al., 2015). Muitos achados são "rugas por dentro" — parte do envelhecer, não sentença de dor.

Isso não significa que exames são inúteis — eles importam em casos específicos. Significa que um laudo cheio de termos assustadores **não condena você ao sofrimento nem ao sedentarismo**. Receber a explicação certa sobre isso, inclusive, já reduz a dor e o medo (educação em dor tem efeito comprovado).

CUIDADO COM O RÓTULO

Termos como "degeneração", "bico de papagaio" e "hérnia" soam graves, mas muitas vezes são achados comuns da idade. **Não deixe um laudo te aposentar do movimento** — interprete-o com um profissional, no contexto do seu caso.

A PESQUISA EM UMA FRASE

Se quase todo mundo "tem desgaste" no exame mas só uma parte sente dor, então o desgaste sozinho **não explica a dor**. O que muda o jogo é o que você **faz** com o corpo — não o que aparece na imagem.

// CAPÍTULO 03

Dor Aguda × Crônica

Nem toda dor é igual. Saber distinguir as duas é o que te diz quando proteger e quando voltar a se mover.

Aguda

RECENTE, LIGADA A UM EVENTO

Surge após um trauma ou esforço, dura dias a poucas semanas. Aqui o alarme costuma refletir bem um dano real — proteja a região no início.

Crônica

PERSISTE ALÉM DA CURA

Continua por meses, muito além do tempo de cicatrização do tecido. Aqui o alarme frequentemente está "sensível demais" — e o repouso piora.

Na dor **aguda**, faz sentido um período curto de proteção relativa (sem imobilidade total) enquanto o tecido cicatriza. Mas a maioria das dores que tira as pessoas do movimento é **persistente**: aquela lombar que vai e volta há anos, o joelho que "incomoda sempre", o ombro que dói no mesmo gesto. Nesses casos, o dano original já cicatrizou — o que sobrou é um sistema de alarme hipersensível.

A REGRA GERAL

Trauma agudo e recente: proteja por alguns dias, depois reintroduza movimento gradual. Dor persistente que já passou do tempo de cura: o caminho quase nunca é mais repouso — é **movimento bem dosado**.

A GRANDE CONFUSÃO

Muita gente trata uma dor crônica como se fosse uma lesão aguda recém-feita — e repousa por meses. É como manter o braço engessado anos depois de o osso ter colado: só gera fraqueza e mais sensibilidade.

// CAPÍTULO 04

O Alarme Sensível Demais

Na dor persistente, o sistema de alarme "aumenta o volume": passa a disparar com estímulos cada vez menores, mesmo sem dano novo.

Quando a dor se prolonga, o sistema nervoso pode ficar mais sensível (um processo chamado sensibilização). É como um alarme de carro tão regulado que dispara quando uma folha cai: o alarme está funcionando "demais", não que haja um ladrão. No corpo, isso significa que movimentos antes normais passam a doer — não porque estão lesionando, mas porque o **volume do alarme** subiu.

O VOLUME DO ALARME



FIG. 04 · na dor persistente, o "ganho" do sistema sobe: pouco estímulo já dispara muita dor. A boa notícia — assim como sobe, esse volume pode **descer** com movimento gradual, sono, menos estresse e a informação certa.

Entender isso é libertador: se a sua dor crônica não é igual a dano novo a cada movimento, você pode (e deve) voltar a se mover. E, ao se expor de forma gradual e segura ao movimento, você ensina o sistema de alarme a **baixar o volume** de novo — o oposto do que o medo e o repouso fazem.

O QUE AUMENTA O VOLUME

Medo, catastrofização ("vou me destruir"), noites mal dormidas, estresse e meses de inatividade. **O que abaixa:** movimento gradual, bom sono, redução de estresse e entender que dói ≠ está se lesionando.

// CAPÍTULO 05

O Ciclo do Medo

É a armadilha que transforma uma dor passageira em um problema de anos. E gira no sentido contrário ao da sua recuperação.

Funciona assim: a dor assusta, o medo faz você evitar o movimento, evitar leva à perda de força e função, o corpo fica mais frágil e sensível — e isso gera **mais dor** ao menor esforço, realimentando o medo. Cada volta do ciclo te deixa mais fraco, mais sensível e mais convencido de que "não pode se mexer".

O CICLO MEDO-DOR (EVITAÇÃO)

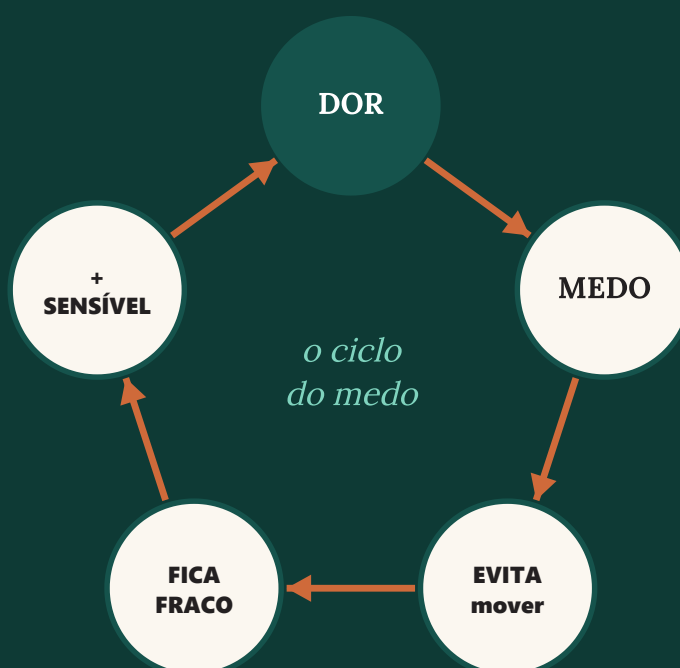


FIG. 05 - o modelo medo-evitação. Quanto mais você evita por medo, mais fraco e sensível fica — e mais dói. Quebrar o ciclo exige fazer o movimento voltar, de forma gradual e sem pânico.

COMO SE QUEBRA O CICLO

Não é com mais repouso — é com **exposição gradual ao movimento**: voltar a fazer, em doses seguras, aquilo que o medo mandou evitar. A cada pequeno sucesso, o cérebro reaprende que mover é seguro, e o ciclo se inverte a seu favor.

Preso há meses nesse ciclo, com medo de se mexer? Eu te ajudo a voltar a se mover com segurança e método.

QUERO VOLTAR A ME MOVER

// CAPÍTULO 06

Movimento é Remédio

Para a grande maioria das dores persistentes, a evidência aponta na mesma direção: mover-se vence repousar.

Diretrizes e revisões sistemáticas são consistentes: para a dor lombar persistente (a mais comum de todas), **manter-se ativo supera o repouso**, e o exercício reduz a dor e a incapacidade — enquanto o repouso prolongado piora tudo. O mesmo vale para tendinopatias (o tratamento é carga progressiva, não parar) e para a maioria das dores musculoesqueléticas crônicas.

↓ dor

EXERCÍCIO

Reduz a intensidade da dor e a incapacidade na dor crônica.

↑ função

MOVIMENTO

Recupera força, confiança e capacidade de fazer a vida normal.

↑ controle

ATIVIDADE

"Dessensibiliza" o alarme e devolve o senso de que você comanda o corpo.



CORPO E MENTE, RECUPERANDO JUNTOS

"MOTION IS LOTION"

O movimento nutre articulações, fortalece tecidos e acalma o sistema de alarme. Não precisa ser intenso — precisa ser **regular e progressivo**. Começar é mais importante que começar perfeito.

// A PARTE PRÁTICA

Dor Inteligente: *Seguir* ou Parar

"Dor não é sinal de parar" não quer dizer "ignore tudo e force". Quer dizer aprender a ler a dor: saber o que é seguro seguir, o que pede cautela — e o que exige parar e procurar ajuda. As próximas páginas te dão exatamente esse critério.



Bandeiras vermelhas

Quando parar e buscar um profissional.

0–10

Dor aceitável

Quanta dor é seguro durante o exercício.



Retorno gradual

Como voltar a se mover, passo a passo.

// RESPONSABILIDADE PRIMEIRO

As Bandeiras Vermelhas

Antes de qualquer "siga em frente": há sinais em que a dor PEDE para parar e procurar avaliação. Conheça-os bem.

▶ PROCURE UM PROFISSIONAL / ATENDIMENTO SE HOUVER:

- ▶ **Trauma significativo** (queda, pancada, torção forte) com dor intensa, inchaço grande ou deformidade.
- ▶ **Dor que piora progressivamente** sem melhora nenhuma ao longo dos dias/semanas.
- ▶ **Dor forte à noite** ou em repouso, que te acorda e não alivia com nada.
- ▶ **Dormência, formigamento ou fraqueza** que se espalha por um membro, ou perda de força real.
- ▶ **Sintomas gerais:** febre, perda de peso inexplicada, mal-estar junto com a dor.
- ▶ **Perda de controle de bexiga/intestino** ou dormência "em sela" (região genital) — isso é emergência.

Estas situações são a **minoria** das dores — mas é por elas que existe a regra de ouro: na dúvida, ou diante de qualquer sinal acima, **avalie com um profissional**. O resto deste guia trata do cenário muito mais comum: a dor persistente, sem bandeiras vermelhas, em que o movimento é parte da solução.

O EQUILÍBRIO CERTO

Nem heroísmo (ignorar sinais graves e forçar), nem pânico (parar tudo por uma fisgada comum). A sabedoria está em **respeitar as bandeiras vermelhas** e, fora delas, voltar a se mover com critério.

POR QUE ISSO VEM PRIMEIRO

Este capítulo vem **antes** de qualquer incentivo a se mover: a segurança vem em primeiro lugar. Descartadas as bandeiras vermelhas, a esmagadora maioria das dores se beneficia de voltar ao movimento — e é disso que tratam as próximas páginas.

// A RÉGUA PRÁTICA

A Escala da Dor Aceitável

Fora das bandeiras vermelhas, como saber quanta dor é "ok" durante o exercício? Use esta régua simples, validada em reabilitação.

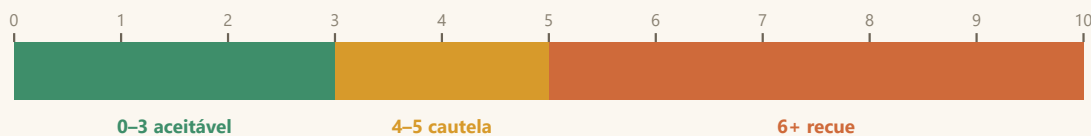
DOR DURANTE E APÓS O EXERCÍCIO (0–10)

FIG. 05 · modelo de monitoramento de dor usado em reabilitação (ex.: tendinopatias): uma dor leve a moderada que se acalma é aceitável; o teste decisivo é como você está no dia seguinte.

- 0– Aceitável.** Desconforto leve que melhora ao aquecer e some depois. Pode seguir, monitorando.
- 4– Cautela.** Dor moderada: reduza a carga, a amplitude ou a velocidade — mas não pare de se mover. Reavalie.
- 6+ Recue.** Dor forte, que altera o seu movimento ou piora durante: diminua bastante ou troque o exercício por hoje.

O TESTE QUE DECIDE TUDO: O DIA SEGUINTE

A regra mais confiável: a dor pode aparecer durante, **desde que volte ao normal em até ~24 h** e não piore treino após treino. Se cada sessão deixa a região pior no dia seguinte, você passou da conta — ajuste a dose.

DOR CONTROLADA NÃO É O INIMIGO

Em reabilitação, um pouco de dor leve durante o exercício **não atrapalha** a recuperação — muitas vezes faz parte dela. O que importa é ficar na faixa aceitável e respeitar o teste do dia seguinte. O alarme aprende que o movimento é seguro.

// O CAMINHO DE VOLTA

Como Voltar a Se Mover

A estratégia se chama exposição gradual: voltar ao movimento em doses que o seu corpo tolera hoje, subindo aos poucos. Devagar, mas sempre para a frente.

- 1 **Comece abaixo do limite.** Escolha uma dose de movimento que provoque pouca ou nenhuma dor (dentro do 0–3). Melhor "fácil demais" do que recair.
- 2 **Seja consistente.** Pouco e frequente vence muito e esporádico. A regularidade é o que reeduca o alarme e reconstrói o tecido.
- 3 **Progrida aos poucos.** Quando uma dose fica confortável por alguns dias, aumente um pouco (carga, amplitude, tempo). Uma variável por vez.
- 4 **Use o dia seguinte como bússola.** Tolerou bem? Mantenha ou avance. Piorou no dia seguinte? Recue um degrau e siga dali.
- 5 **Respeite altos e baixos.** Recaídas pontuais são normais e não significam que você "se destruiu". Ajuste a dose e continue — não abandone.

O PRINCÍPIO EM UMA FRASE

Acalme, depois fortaleça. Primeiro reduza a sensibilidade voltando ao movimento tolerável; depois construa força e capacidade progressivas, até o corpo aguentar o que você quer fazer.

PACIÊNCIA ESTRATÉGICA

Dor persistente costuma melhorar em semanas a meses, não em dias. Pense em **tendência**, não em cada dia isolado. O gráfico é de altos e baixos — mas, bem conduzido, aponta para cima.

// ★ SEU PLANO

Seu Plano de Retorno

Monte a sua escada de exposição gradual: do movimento que você tolera hoje até a atividade que você quer recuperar. Suba um degrau por vez.

DEGRAU	MOVIMENTO / ATIVIDADE	DOSE (SÉRIES/TEMPO)	DOR (0-10)
1 (hoje)	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____
Meta	_____	_____	_____

COMO USAR A ESCADA

No degrau 1, ponha algo bem tolerável **hoje**. No topo, a atividade que você quer voltar a fazer (correr, agachar, brincar com os filhos). Suba quando o degrau atual estiver confortável e o dia seguinte, tranquilo. Anote a dor para enxergar a tendência.

O PULO DO GATO

Ter a escada no papel transforma "tenho medo de me mexer" em "qual é o meu próximo degrau?". O foco sai da dor e vai para o **progresso** — e isso, por si só, já ajuda a acalmar o alarme.

// CAPÍTULO 07

A Mente Importa

Se a dor é um alarme do cérebro, então o que você pensa, sente e dorme regula o volume dela. Isso não é "frescura" — é fisiologia.

A própria informação que você está lendo já é tratamento: a **educação em dor** — entender que dói ≠ dano e que o corpo é forte e adaptável — reduz, comprovadamente, a dor, a incapacidade, o medo do movimento e a catastrofização. Quando o cérebro percebe menos ameaça, ele baixa o alarme.

- ☐ **Crenças.** Trocar "minha coluna está destruída" por "minha coluna é forte e adaptável" muda a percepção de ameaça — e a dor.
- ☐ **Sono.** Noites ruins aumentam a sensibilidade à dor no dia seguinte. Dormir bem é analgésico natural.
- ☐ **Estresse.** Estresse e ansiedade "turbina" o alarme. Técnicas de respiração, lazer e contato social ajudam a baixá-lo.
- ☐ **Catastrofização.** Imaginar o pior amplifica a dor. Reconhecer esse padrão e reformulá-lo reduz o sofrimento.

NÃO É "ESTÁ NA SUA CABEÇA"

A dor é **sempre real** — nunca imaginária. Dizer que a mente influencia não é negar a dor; é reconhecer que temos **mais ferramentas** para tratá-la do que só remédio e repouso.

// CUIDADO

Os Dois Extremos

Errar para os dois lados atrapalha. Fuja tanto do excesso de medo quanto do excesso de heroísmo.

Erros de quem tem medo demais

- ☐ **Parar tudo por meses** diante de uma dor comum — e colher fraqueza, rigidez e mais sensibilidade.
- ☐ **Deixar um laudo te aposentar.** Tratar "desgaste" de exame como sentença e evitar o movimento para sempre.
- ☐ **Catastrofizar.** Acreditar que qualquer dor é destruição — o que aumenta o volume do alarme.

Erros de quem força demais

- ☐ **Ignorar bandeiras vermelhas** e "empurrar com a barriga" uma dor que pedia avaliação.
- ☐ **Querer voltar de uma vez**, pulando degraus, e recair toda hora.
- ☐ **Mascarar a dor com remédio** para treinar igual, sem ajustar a dose nem entender a causa.

***Nem fugir da dor,
nem brigar com ela.
Aprenda a lê-la.***

// A VIRADA

O Que Muda Quando Você Entende a Sua Dor

Sair do medo e voltar a se mover com segurança não é só sobre a dor — é sobre recuperar a sua vida.

+liberdade

VIDA DE VOLTA

Voltar a treinar, brincar, viajar — sem organizar tudo em torno da dor.

–medo

MENOS PÂNICO

Entender a dor tira o desespero e devolve o senso de controle.

+força

CORPO ROBUSTO

Mover e fortalecer torna o corpo mais resistente e menos sensível.

O desafio é fazer isso com segurança: distinguir as bandeiras vermelhas, dosar o movimento na medida certa, progredir sem recair e não desistir nas oscilações. É exatamente aí que ter um profissional ao lado muda o jogo — alguém que avalia o seu caso, descarta o que precisa ser descartado e constrói o seu retorno com você.

O CAMINHO MAIS SEGURO

Em vez de viver no medo ou arriscar no escuro, tenha um **plano de retorno guiado**: avaliação séria, exposição gradual bem dosada e acompanhamento para você voltar a se mover com confiança.

// COMO EU POSSO TE AJUDAR

Retorno Seguro ao Movimento

Eu avalio o seu caso, ajudo a separar o que é seguro do que pede atenção, e monto um plano de exposição gradual para você voltar a se mover — com acompanhamento.

Avaliação & Plano de Retorno

EXPOSIÇÃO GRADUAL + FORÇA + ACOMPANHAMENTO

- ✓ **Avaliação do seu caso** — histórico, sinais de alerta e o que você quer voltar a fazer.
- ✓ **Triagem das bandeiras vermelhas** — e encaminhamento, se for necessário.
- ✓ **Plano de exposição gradual** — a sua escada, dosada para o seu corpo hoje.
- ✓ **Força e capacidade progressivas** — para um corpo robusto e menos sensível.
- ✓ **Acompanhamento** nas oscilações, com suporte no WhatsApp.



AValiação e Acompanhamento — Presencial ou à Distância

Quero voltar a me mover · WhatsApp

// SEM COMPLICAÇÃO

Como Funciona

1

Conversa

Você me chama no WhatsApp e conta a sua dor e a sua história.

2

Avaliação

Vemos o seu caso, triamos sinais de alerta e definimos o ponto de partida.

3

Retorno

Você sobe a escada de movimento e a gente ajusta junto.

"E se eu me machucar mais ao me mexer?"

Por isso começamos abaixo do seu limite e progredimos pelo dia seguinte. Exposição gradual e bem dosada é segura — e é o oposto de "forçar".

"Tenho uma hérnia/desgaste no exame. Posso treinar?"

Quase sempre sim — esses achados existem em muita gente sem dor. Avaliamos o seu caso e montamos um plano seguro para você.

"Você substitui o médico/fisioterapeuta?"

Não. Eu trio sinais de alerta e te encaminho quando preciso; meu trabalho é a parte de movimento e força do seu retorno, em conjunto.

"Funciona à distância?"

Sim. Avaliação, plano e acompanhamento podem ser online. Me chame para ver o seu caso.

Convive com uma dor que vai e volta e te trava? Me chama — vamos montar o seu caminho de volta ao movimento.

QUERO VOLTAR A ME MOVER

// POR QUE AGORA

Quanto Mais Você Evita, Mais o Alarme **Sobe**

O ciclo do medo não fica parado: a cada mês de evitação, o corpo enfraquece mais e o alarme fica mais sensível. O tempo, sozinho, joga contra.

Esperar "a dor passar para depois voltar a se mover" é a armadilha mais comum — porque, na dor persistente, é justamente o **movimento** que faz a dor passar, não o contrário. Cada temporada parado é mais força perdida, mais medo enraizado e um sistema de alarme mais difícil de recalibrar. Quanto antes você começa o caminho de volta, mais curto ele é.

Você já tem o mapa: entende o que é a dor, sabe que dói ≠ dano, reconhece as bandeiras vermelhas e tem a lógica da exposição gradual. O que falta é aplicar com segurança e constância, com alguém que avalia o seu caso e ajusta o caminho. É a diferença entre mais um ano em volta da dor e o ano em que você **retoma a sua vida**.

A REAL

O corpo humano é **forte e adaptável** — feito para se mover, não para se proteger eternamente. Confie nisso, comece pequeno e seguro, e dê ao seu corpo a chance de provar do que ele é capaz.

*O caminho de volta
começa com um **passo seguro**.*

Começar agora · Falar no WhatsApp

Cartão da *Dor Inteligente*

► PARE E PROCURE AJUDA SE HOUVER

Trauma forte · dor que só piora · dor noturna intensa · dormência/fraqueza num membro · febre/perda de peso · perda de controle de bexiga/intestino.

A escala da dor (durante o exercício)

NOTA	O QUE FAZER
0-3	Aceitável — pode seguir, monitorando
4-5	Cautela — reduza carga/amplitude, não pare
6+	Recue — diminua bastante ou troque hoje

O TESTE DO DIA SEGUINTE

A dor pode aparecer durante, **desde que volte ao normal em ~24 h** e não piore treino após treino. Esse é o melhor termômetro.

AS 3 VERDADES QUE LIBERTAM

1. Dor é um alarme, não medidor de dano. 2. Achado de exame ≠ causa da dor. 3. Movimento gradual baixa o volume do alarme.

// O PRÓXIMO PASSO

Volte a se mover — com *segurança*.

Você entende a sua dor de um jeito novo: um alarme que pode ficar sensível, e que o movimento gradual ajuda a acalmar. Falta dar o passo com segurança — com uma avaliação que separa o que pede atenção, uma escada de exposição na medida certa e acompanhamento nas oscilações. É assim que se sai do ciclo do medo e se volta a viver e treinar.

Avaliação & Plano de Retorno

Triagem + exposição gradual + força + acompanhamento. A mesma ciência deste guia, aplicada com cuidado ao seu caso.

Agendar avaliação no WhatsApp · (31) 9 9329-0622

WHATSAPP

INSTAGRAM

SITE

(31) 9 9329-0622

@preparadorfisico_gustavo

seuproximonivelestaqui.com.br

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS // QUALIS A1-A2

Brinjikji W. et al. "Systematic Literature Review of Imaging Features of Spinal Degeneration in Asymptomatic Populations". American Journal of Neuroradiology, 2015 [A1]. · Moseley GL, Butler DS. "Explain Pain / pain neuroscience education" (base da educação em dor) [A1]. · Revisões sistemáticas: educação em dor reduz dor, incapacidade e cinesiofobia na dor crônica [A1]. · Diretrizes: manter-se ativo e exercício superam o repouso na dor lombar persistente [A1]. Material educativo; NÃO substitui avaliação médica. Diante de dor intensa pós-trauma ou bandeiras vermelhas, procure atendimento.